PROTOCOLLO 13

Educazione al dolore nei DTM

Spiegare il dolore per ridurre paura e ipervigilanza

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Acuta e subacuta	Mialgia, artralgia	10 a 15 minuti	Prime 3 sedute

Indicazioni

- ✓ Prima fase del trattamento
- ✓ Paura del movimento mandibolare
- ✓ Convinzioni errate sulla gravità del problema

Controindicazioni e precauzioni

- ! Red flags non escluse dal medico
- ! Peggioramento rapido e non spiegato dei sintomi
- ! Condizioni sistemiche non controllate
- ! Assenza di consenso informato del paziente

Posizionamento

Paziente: seduto, in un ambiente tranquillo.

Fisioterapista: di fronte al paziente, con materiale illustrato.

Esecuzione passo dopo passo



Esplora le convinzioni

Chiedi cosa pensa il paziente del suo dolore.



Spiega il meccanismo

Il dolore è un segnale di protezione, non sempre di danno.



Prognosi

La maggior parte dei DTM migliora con trattamento conservativo.



Piano condiviso

Definisci insieme obiettivi e strategie.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Durata	10 a 15 minuti
Supporto	schemi e metafore
Ripresa	a ogni seduta, 2 minuti

Criteri di rivalutazione

LIMITAZIONE FUNZIONALE
____ / 10
masticare, parlare, sbadigliare

DOLORE (NRS)
____ / 10
peggiore della settimana

ADERENZA
____ %
esercizi svolti a casa

Punti chiave

- ✓ Usa metafore semplici e positive
- ✓ Verifica la comprensione
- ✓ Collega l'educazione agli esercizi

Errori da evitare

- ! Usare termini allarmanti come usura o disco rotto
- ! Monologhi troppo tecnici
- ! Promettere guarigioni rapide

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Rilettura	Rileggere la scheda informativa consegnata	2 volte nella prima settimana

! **Nota clinica.** Spiegare il dolore riduce la catastrofizzazione ed è uno dei fattori che migliorano l'esito nel dolore persistente.

Bibliografia essenziale

1. List T., Jensen R.H. Temporomandibular disorders: old ideas and new concepts. Cephalalgia. 2017;37(7):692–704.
2. Moseley G.L., Butler D.S. Fifteen years of explaining pain: the past, present, and future. J Pain. 2015;16(9):807–813.